EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	87181
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2024-06-24 10:20:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA INES AVILA SOTO			RUN	: 6.643.974-7
F.Nac	: 09-08-1951	Edad	: 72 AÑOS, 10 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: SARGENTO ALDEA 444			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-04	Fecha Egreso	: 2024-06-24 10:20:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda, resuelta
- NAC bibasal
- Derrame pleural derecho (Instalacion SEP 15/06/24) --> Exudado
2. ICC descompensada, FEVI 58%, en vías de compensación
- Anasarca
- Insuficiencia Mitral Severa
- Miocardiopatía dilatada
3. FA rápida con CVE (04/06) en tratamiento anticoagulante
4. Insuficiencia renal aguda KDIGO2 No oligúrica, resuelta.
5. Hipernatremia en vías de resolución
6. HTA
7. Policitemia Vera
8. Herpes Genital.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, policitemia Vera, ICC y FA en TACO con mala adherencia a tratamiento
Consulta en SU HSC por cuadro de aprox un mes de evolución caracterizado por edema progresivo de extremidades inferiores asociado a disnea y tos productiva

Ingresa a SU en malas condiciones generales, con FA rápida, se manejó con lanatosido C con respuesta parcial, además se inició tratamiento depletivo y se inició tto ATB con ceftriaxona por elevación de parámetros inflamatorios y foco de condensación den RxTx.
Se solicita evolución por residente UTI y se constata paciente en FA rápida con hemodinamia inestable por lo que se decide CVE con 100J y posterior carga amiodarona con BIC de mantención e inicio de BIC heparina por LRA KDIGO 2
Se decide ingreso a unidad para monitorización y manejo médico de de patologías descompensadas
Durante estancia en UTI paciente en regulares condiciones, con requerimiento de O2, persistiendo con compromiso, inciando con terapia ATB de amplio espectro. Se toman estudios de imagen requeriendo SEP, el cual se instala sin complicaciones. Persiste con drenaje positivo, descenso de parámetros inflamatorios, disminución de requerimiento de O2. Se retira SEP por mejoría.
Infeccioso: Con diagnóstico de Neumonia desde su ingreso en tratamiento con tazonam. Se plantea inicialmente completar 10 días de tratamiento. El 15/06/24 se pesquisa derrame pleural derecho moderado/severo por lo que se instala SEP, analisis evidencia exudado, por lo que se decide prolongar atb hasta rescatar resultado de cultivo de liquido pleural el cual reporta negativo. No se logró muestra de CSB, UC (-), antígenos virales (-), panel viral (-). Vigilancia activa de parámetros inflamatorios.
En vista de ausencia de requerimiento de oxígeno y mejoría general, se considera alta médica. Persiste con limitación leve motora y respiratoria, la cual amerita seguimiento por KNT. Se deriva a HODOM para continuidad de atención.

INDICACIONES AL ALTA

1. Omeprazol 20 mg al dia vo
2. Levotiroxina 100 ug 1 comprimido al dia vo (en ayunas, 30 minutos antes del resto de fármacos)
3. Dabigatran 150 mg c/12 hrs vo
4. Sacubitrilo/Valsartan 50 mg al dia vo
5. Furosemida 40 mg al día vo
6. Amlodipino 10 mg/día vo
7. Espironolactona 25 mg al día vo
8. Slow K 600 mg 2 comp c/6 hrs vo
9. Bromuro de Ipratropio 4 puff c/6 hrs c/AC
10. Paracetamol 1 gr c/8hrs ev SOS
11. KNT Motora / KNT Respiratoria diario - Ajustar según valoración KNT

12. Control en APS en 2 meses con TSH -T4L (eventual reajuste de levotiroxina)
13. Control poli medicina <1 mes

EXÁMENES Y RESULTADOS

19/06/24: Crea 1.0, PCR 47, ELP 151/3.6/121, GB 7500, Hb 10.9, PQT 166000, INR 1.58, GSA pH 7.49 pO2 75 pCO2 32 HCO3 24 Sat 94% FiO2 21%
18/06/24: Crea 1.0 PCR 41, Uremia 60, ELP 154/3.8/123, INR 1.60, Hb 10.5, GB 7600, PQT 164000. GSA pH 7.51 pO2 83 pCO2 34 HCO3 28 Sat 97% FiO2 24%
17/06/24: Crea 1.1, PCR 25.8, BUN 34, ELP 154/3.3/123, INR 1.48 GSA pH 7.51 pO2 69 pCO2 36 HCO3 29 Sat 93% FiO2 24%
16/06/2024: Crea 0.8, PCR 15.7, ELP 155/3.6/122, Leuco 7.400, Hcto 38.9, Hb 11.8, Plaquetas 136, INR 1.28, TTPA 38, Ph 7.5. PCO2 39.7, PO2 71.9, HCO3 30.9.
15/06/24: Crea 0.9, Uremia 95, ELP 156/3.2/118, GB 8700, Hb 11.9, Pqt 140000, INR 1.19
14/06/24: Crea 1.0 ELP 158/3.1/117 PCR 16.5 INR 1.15 ProBNP 1520 GSA pH 7.50 pO2 76 pCO2 46 HCO3 36 Sat 95% FiO2 34%
13/06/2024: Crea 1.0, PCR 20, Uremia 111, ELP 161/3.4/118, Hb 14.5, GB 15100 PQT 138000 INR 1.34 GSA pH 7.51 pO2 78 pCO2 49 HCO3 39 Sat 96% FiO2 34%
12/06/2024: Crea 1.2, PCR 28, Uremia 105, ELP 161/3.2/115, INR 1.36, Hb 15.6, PQT 142000, Hto 52%, GSA pH 7.53 pO2 62.1 pCO2 49.9 HCO3 41 Sat 90% FiO2 34% PaFi 182
11/06/24: Crea 1.2, PCE 46, Uremia 89, ELP 1554/3.9/106, GB 12800, Hb 14, Plq 143000, INR 1.35, GSA pH 7,55 pO2 72.8 pCO2 50.5 HCO3 44 Sat 95% FiO2 34% PaFi 212
08/06/24: Crea 1.5, PCR 76, Uremia 111, ELP 148/2.8/99, Hb 12.7, Plaquetas 98000, GB 10500. GSA pH 7,5 pO2 99,3 pCO2 48 HCO3 37 Sat 98% FiO2 32%
07/06/24: crea 2,1 Uremia 136 ELP 143/2,9/101 TTPA52 PCR 190,4
05/06/24: Albumina : 2,0 * g/dL, Creatinina : 2,50 * mg/dl, Calcio : 7,3 * mg/dL, Fosforo : 5,0 * mg/dl, LDH : 366 * U/L, Clearence Calculado(MDRD) : 18,93 ml/min/1,73, Lactato : 2,8 * mmol/L,Proteina C Reactiva : 310,5 * mg/L, Uremia : 132 * mg/dl, Magnesio : 2,30 mg/dL, Sodio (Na) : 133,00 * mmol/L, Potasio (K) : 4,60 mmol/L, Cloro (Cl) : 101,00 mmol/L, Recuento de leucocitos : 17,20 * mil/ul, Recuento Hematies : 6,40 * Mill/ul, Hematocrito : 44,6 %, Hemoglobina : 13,7 g/dl, Plaquetas : 200 mil/ul, INR : 2,76 *, Tiempo de Protrombina % : 27 *%, Tiempo de Protrombina seg : 34,4 seg, TTPA (seg) : 48 *, pH : 7,42, pCO2 : 32,1 * mmHg, pO2 : 77,4 * mmHg, HCO3 ACT. : 21,1 * mmol/L.

Ecocardiograma (07/06/24)
1. VENTRÍCULO IZQUIERDO LEVEMENTE DILATADO. SIN ALTERACIONES DE LA MOTILIDAD GLOBAL NI SEGMENTARIA. FRACCION DE EYECCION NORMAL (58%). DISFUNCIÓN DIASTÓLICA GRADO II.
2. AURÍCULA IZQUIERDA SEVERAMENTE DILATADA.
3. INSUFICIENCIA MITRAL SEVERA FUNCIONAL.
4. AURÍCULA DERECHA SEVERAMENTE DILATADA. INDICES DE FUNCION SISTÓLICA DEL VD NORMALES. SIGNOS DE HIPERTENSION PULMONAR.
5. INSUFICIENCIA TRICUSPÍDEA SEVERA FUNCIONAL.
6. ENFERMEDAD DEGENERATIVA VALVULAR AÓRTICA CON INSUFICIENCIA LEVE

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO